

**Phẫu thuật treo âm đạo (vaginal suspension) sửa chữa sa đỉnh âm đạo hoặc tử cung** bằng cách neo lại vào các dây chằng chắc khỏe trong vùng chậu — dùng **mô của chính bạn**, không lưới. Toàn bộ thực hiện qua âm đạo, không cần rạch bụng, là cách bền vững và không lưới để phục hồi độ nâng đỡ và chiều sâu âm đạo.

## Về ca phẫu thuật này

Vòm âm đạo được khâu vào một dây chằng chắc trong vùng chậu để giữ đỉnh không bị sa. Hai phương pháp phổ biến:

- **Treo dây chằng tử cung-cùng (USLS)** — neo vào dây chằng tử cung-cùng sâu trong vùng chậu
- **Cố định dây chằng cùng-gai (SSLF)** — neo vào dây chằng cùng-gai về phía bên

Cả hai đều dùng **mô của chính bạn** (mũi khâu vĩnh cửu), không cần lưới. Thường được kết hợp với sửa thành trước hoặc sau âm đạo và, khi cần cắt tử cung, thực hiện cùng một lần.

## So sánh với các phương pháp khác

So với **treo cổ bàng quang bằng lưới qua bụng (sacrocolpopexy)**, phẫu thuật treo âm đạo tránh dùng lưới và không cần rạch bụng; sacrocolpopexy có thể bền hơn một chút. Bác sĩ phẫu thuật sẽ giúp bạn cân nhắc ưu và nhược điểm.

## GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ

### Đỉnh / vòm âm đạo

Phần trên cùng của âm đạo, có thể bị sa xuống.

### Treo (Suspension)

Neo lại đỉnh âm đạo vào dây chằng chắc khỏe.

### USLS

Treo dây chằng tử cung-cùng.

### SSLF

Cố định dây chằng cùng-gai.

### Mô tự thân

Mô của chính bạn — không dùng lưới trong kỹ thuật này.

### Sa vòm âm đạo

Đỉnh âm đạo bị sa, thường gặp sau cắt tử cung.

**CÓ ĐAU KHÔNG?** Phẫu thuật được thực hiện dưới gây mê nên bạn không cảm thấy gì trong lúc mổ, và không có vết rạch bụng. Với phương pháp SSLF, một số người có thể thấy **đau hông hoặc đùi trên** trong vài ngày đến vài tuần khi vết thương lành — thường tự khỏi.

## Cách chuẩn bị

- Thực hiện theo **hướng dẫn gây mê** (nhịn ăn, ngừng thuốc làm loãng máu theo chỉ định).
- Khám đánh giá trước mổ; có thể kết hợp sửa chữa thêm hoặc phẫu thuật chống rò rỉ nước tiểu.
- Không hút thuốc; sắp xếp người đưa về và giúp đỡ tại nhà.

## Quá trình phẫu thuật

- 1 Bạn được gây mê; kháng sinh được dùng trước mổ.
- 2 Qua âm đạo, đỉnh âm đạo được khâu vào dây chằng vùng chậu chắc khỏe.
- 3 Các sửa chữa thành âm đạo kèm theo được thực hiện theo kế hoạch.
- 4 Ống thông và đôi khi gạc âm đạo được đặt trong thời gian ngắn.

## Sau phẫu thuật

- Về nhà trong ngày hoặc sau một đêm; ra máu nhẹ hoặc dịch âm đạo là bình thường.
- Tránh nâng vật nặng, rặn và quan hệ tình dục trong khoảng 6 tuần.**
- Đau hông (với SSLF) thường giảm dần sau vài tuần; giữ phân mềm.

### Hãy gọi cho nhóm chăm sóc nếu bạn có:

- Sốt hoặc ớn lạnh, hoặc chảy máu nhiều
- Không thể đi tiểu** được, hoặc đau vùng chậu ngày càng tăng
- Đau hông hoặc chân dữ dội hoặc lan xuống**, hoặc tê mới xuất hiện

## BA ĐIỀU CẦN NHỚ

1. Treo âm đạo nâng đỉnh âm đạo bằng dây chằng của chính bạn — bền, không lười, thực hiện qua âm đạo.
2. Hai phương pháp phổ biến là USLS và SSLF; sacrocolpopexy là lựa chọn dùng lưới qua bụng nếu bạn muốn so sánh.
3. Tránh nâng vật nặng và quan hệ khoảng 6 tuần. Đau hông nhẹ có thể xảy ra với SSLF; gọi ngay nếu sốt, chảy máu nhiều hoặc đau chân/mông dữ dội.